

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LEANDRO ALBERTO DA SILVA

IDADE: 40 PESO: 103 ALTURA: 170 PROFISSÃO: *Autônomo*SINTOMAS: *causado / boca seca /*QUEIXAS: *acorda q rouco / acorda engasgado*MEDICAMENTOS: *Rosuvastatina*
Aspirina / ↑ glicose / ↑ colesterol

MÉDICO:

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ NEXERCÍCIO FÍSICO: *não faz (tem hernia de disco)*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: — ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (22)

HORA QUE DORME: 19h-23 HORA QUE ACORDA: 5-6h

COCHILHO: ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: ☒ S () N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N *Final Semana*FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: *Parou*TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: 1 a 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 65.4 SPO2: 69%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Bronquite*
*Rinite*CIRURGIAS: () S NASAL () S AMIGDALECTOMIA *Desvio septo*

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () S RESPIRATÓRIA () N ENDÓCRINA () S CARDÍACA *Arritmia*() S ORTOPÉDICA *Dor na* () NEUROLÓGICA () OUTROS: *Cateeterismo*POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: N PRESSÃO NO EXAME: N19/04/25 *Avaliação + colocação*26/04/25 *P=10.3 cmH2O*IAH: *1.5 cmH2O*m de uso: *4h57'*fluxo: *4.5 l/min**Relata estar muito bem adaptado. Orienta sobre abertura de boca**fixo pressão 10.2 cmH2O**varia 5 min 7 cmH2O**Natácia*

08/05/25 P= 10,2 cmH₂O
IAH: 1,3 e/h
m de ura: 7h47'
fuga: 15,7 l/m

Bem adaptado
6/ queixas
Natacho

14/06/2025 P= 10,2 cmH₂O
IAH: 1,8 e/h
m de ura: 7h09.
fuga: 10 l/min

Sem queixas

Semi



Nome: **LEANDRO ALBERTO DA SILVA**
Sexo: **Masculino** Idade: **40 anos**
Peso: **102 kg** Altura: **170 cm**

Exame nº: **34293878840**
Data: **11-03-2025**

Laudo de Polissonografia: Resultado

O exame foi iniciado às 11/03/2025 20:56 e finalizado às 12/03/2025 05:35. A **latência para início do sono** foi de 17,5 min e a **latência para o sono REM** de 116,0 min. O **tempo total de sono (TTS)** foi de 455,3 min, com **eficiência do sono** de 88,4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 2,6% de **estágio N1**, 67,1% de **estágio N2**, 9,4 de **estágio N3** e 20,9% de **sono REM**. O **tempo acordado após o adormecer** foi 35,2 min. Ocorreram 329 **despertares**, sendo o índice de 43,4 (nº/h).

O **índice de movimento periódico de membros inferiores** foi de 0,0 (nº/h), sendo 0 **associado a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 439, sendo 170 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas e 269 hipopneias. O **índice de apneia/hipopneia (IAH)** foi de 65,4 (nº/h), sendo 25,3 apneia/h e 40,1 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 93%, a **média** de 91% e a **mínima** de 69%. O **índice de dessaturação** foi de 50,0 (nº/h) durante o sono REM e de 58,0 (nº/h) durante o sono NREM. Permaneceu 17,7% do tempo total de sono com SpO₂ abaixo de 90%.

Não apresentou respiração de Cheyne-Stokes.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apneia + Hipopneia + RERA

Conclusões:

1. Eficiência do sono normal.
2. Redução do percentual de sono de ondas lentas (N3). Normalidade no percentual de sono REM.
3. Aumento no número de despertares.
4. Aumento acentuado no índice de apnéia/hipopnéia (IAH) por eventos obstrutivos. **(65,4/h)**.
5. Dessaturação da oxi-hemoglobina relacionada aos eventos respiratórios. **(SpO₂ min 69%)**.
6. Ronco presente.


Dr. Carlos Alberto Basso
Otorrinolaringologia
CRM/SP 55718